



GUIA PARA PACIENTES

Joanete (hálux valgo): o que ajuda e quando operar

o que alivia, o que nenhum aparelho corrige e quando a cirurgia faz sentido

Por que o joanete aparece, o que de fato alivia a dor, o que os "corretores" não conseguem fazer e quando a cirurgia passa a ser uma conversa séria.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **JOANETE**

Para quem é:

Para quem tem joanete, aquele "osso" saliente na lateral do pé, na base do dedão, e sente **dor ou incômodo para calçar, sem nenhum sinal de alerta da próxima página.**

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem tem diabetes com ferida, bolha ou pouca sensibilidade no pé: avaliação antes de qualquer medida deste guia.
- Quem operou o joanete há pouco tempo: siga as orientações da equipe que operou.
- Crianças e adolescentes com joanete: a avaliação é diferente e deve vir antes (opinião clínica).

O que você vai precisar:

- Os sapatos que você mais usa, para revisar com a Página 6.
- Uma cadeira firme para os exercícios da Página 7.
- Uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

Aliviar a dor sem cirurgia é possível. **Corrigir** o joanete sem cirurgia, a ciência não mostrou.

Desconfie de qualquer produto que prometa o contrário.

O joanete costuma incomodar devagar, ao longo de anos. Mudança brusca é outra história. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure atendimento HOJE se:

- A região do dedão ficou **vermelha, quente e inchada de repente**, com dor forte até ao toque do lençol. Pode ser crise de **gota** ou, mais raramente, **infecção** na articulação, ainda mais se houver **febre** (opinião clínica).
- Você tem **diabetes** e apareceu **ferida, bolha, área escura ou secreção** no joanete ou entre os dedos. No pé de quem tem diabetes, uma lesão pequena pode piorar rápido. A diretriz internacional recomenda tratar qualquer lesão antes que ela vire úlcera [14].
- O pé ficou **frio, pálido ou arroxeadado**, ou surgiu **dormência** nova (opinião clínica).
- Apareceu **dor intensa e súbita**, com dificuldade para apoiar o pé, depois de torção ou batida (opinião clínica).

Procure avaliação em poucos dias se:

- Você tem diabetes ou pouca sensibilidade nos pés e o sapato está **machucando** o joanete [14].
- O calo sobre o joanete **abriu ou sangrou**.

Uma observação honesta: a grande maioria dos joanetes nunca chega a nada disso. Esta página serve para separar o que pode esperar do que não pode.

Um dedão que entortou

No joanete (hálux valgo), o **dedão desvia em direção aos outros dedos** e o osso da base dele (o 1º metatarso) se projeta para dentro. Essa saliência é o "osso" que aparece na lateral do pé. Ela roça no sapato, inflama e forma calo. Com o tempo, o dedão pode empurrar o segundo dedo.

É muito comum

Uma revisão mundial estimou joanete em cerca de **1 em cada 5 pessoas**: perto de 24% das mulheres e 11% dos homens, com mais casos depois dos 60 anos [1].

Por que aparece

- **Família:** num grande estudo americano, o joanete mostrou **forte herança familiar** [2].
- **Ser mulher e envelhecer** [1][3].
- **Sapato de bico fino e apertado:** uma revisão de 2026 encontrou associação mais forte com bico estreito do que com salto alto [3]. Em mulheres, o salto alto também aparece associado [4].

Honestidade: associação não prova causa. Há quem nunca tenha usado salto e tenha joanete, e quem usou a vida toda e não tenha. Joanete **não é culpa sua**. O que o sapato certamente faz é **piorar ou aliviar a dor** (opinião clínica).

Separadores de dedos, talas de dormir, "corretores" e exercícios costumam ser vendidos como capazes de **corrigir** o joanete. Veja o que os estudos mostram:

- Uma revisão de 2022 reuniu 18 estudos de tratamentos sem cirurgia. A maioria era pequena e com risco de viés. Conclusão: a certeza é **baixa**, e **aliviar a dor** parece mais provável do que **melhorar o ângulo** do dedão [5].
- Alguns estudos pequenos mostram redução de **poucos graus** no ângulo com separadores ou com exercícios, em joanetes leves e moderados [6] [7]. Não há estudo de boa qualidade mostrando que essa redução **dura** ou que **evita a cirurgia** (opinião clínica, a partir das revisões [5][9]).
- Num estudo controlado finlandês, a palmilha ortopédica aliviou a dor nos primeiros meses. A conclusão dos autores: alívio **de curto prazo** [8].
- Uma revisão alemã de 2025 resume: fisioterapia, palmilhas e talas podem aliviar o desconforto em algumas pessoas, mas **não mudam a deformidade**, que tende a progredir [9].

Tradução: produto que promete "corrigir" o joanete promete mais do que a ciência mostra. Para **aliviar**, algumas medidas ajudam. Elas estão na próxima página.

O objetivo é **tirar a pressão de cima do joanete**. Calçado com espaço é a orientação da revisão de 2025 [9]. Protetor e palmilha têm pouca pesquisa: os detalhes abaixo são opinião clínica.

Medida 1 — Sapato com espaço na frente

Como fazer: prefira bico largo e alto, material macio e salto baixo [9].

Experimente no fim do dia, em pé, com a meia que vai usar.

Sensação correta: os dedos se mexem dentro do sapato e nada aperta o joanete.

Erro comum: escolher pelo número, e não pelo formato, ou esperar que o sapato apertado "lacie".

Medida 2 — Protetor de joanete

Como fazer: almofada de gel ou silicone sobre a saliência, só em sapato com espaço para ela.

Sensação correta: menos atrito e menos ardência no fim do dia.

Erro comum: colocar o protetor dentro de um sapato que já aperta. Fica mais apertado.

Medida 3 — Palmilha

Como fazer: palmilha orientada depois de avaliação do pé. Num estudo, aliviou a dor no curto prazo [8].

Sensação correta: apoio confortável, sem ponto de pressão novo.

Erro comum: usar palmilha alta que "sobe" o pé e aperta o joanete contra o sapato.

Remédio para dor: este guia não indica remédio nem dose. Converse com seu médico.

Antes de começar: a evidência é **limitada**. Estudos pequenos mostram algum alívio da dor e redução de poucos graus no ângulo [5][7]. Exercício não substitui a cirurgia quando ela é indicada. A escolha destes 3 é opinião clínica: o objetivo é manter o dedão móvel e os músculos do pé ativos.

Regra: dor leve e passageira é aceitável. Dor que aumenta: pare.

Exercício 1 — Afastar o dedão

Como fazer: sentado, pé descalço no chão. Tente afastar o dedão dos outros dedos, sem mexer o pé. Segure 5 segundos. 10 vezes.

Sensação correta: um músculo trabalhando na borda interna do pé. O dedão mexe pouco, e isso é normal.

Erro comum: dobrar os dedos ou girar o pé para "ajudar".

Exercício 2 — Pé curto

Como fazer: sentado, pé no chão. "Encurte" o pé, puxando a base do dedão em direção ao calcanhar, sem dobrar os dedos. Segure 5 segundos. 10 vezes.

Sensação correta: o arco do pé sobe e os dedos continuam esticados no chão.

Erro comum: encolher os dedos em garra.

Exercício 3 — Mobilizar o dedão

Como fazer: segure o dedão com a mão e leve-o para cima e para baixo, devagar. 10 vezes.

Sensação correta: alongamento leve, sem dor aguda.

Erro comum: puxar o dedão com força para "endireitar".

Quantas vezes: 1 a 2 vezes ao dia.

Cirurgia é para dor e limitação, não para estética

A indicação existe quando há **dor importante, limitação para andar ou calçar, piora da qualidade de vida ou feridas de pressão repetidas**, e cerca de 3 meses de tratamento sem cirurgia não resolveram [9]. Uma entidade americana de cirurgiões de pé e tornozelo afirma que cirurgia **só para mudar a aparência** traz risco sem benefício médico e não deve ser feita [11].

O que a pesquisa mostra

- Num estudo com 209 pacientes, após 1 ano, **83%** dos operados se sentiam melhor, contra **24%** dos que só observaram [8].
- Uma revisão Cochrane de 2024 (25 estudos) concluiu que a cirurgia **pode** reduzir a dor de forma importante, mas com certeza **baixa** [10].

Recuperação, em linhas gerais [9]

- 2 primeiras semanas: pé elevado; muletas, conforme a técnica.
- Sapato especial por cerca de **6 semanas**.
- Inchaço que pode limitar os sapatos por semanas a meses.
- Trabalho sentado: cerca de 4 semanas. Em pé: até cerca de 12.

Varia com a técnica e a pessoa.

Riscos e recidiva

Numa análise, as complicações somaram **18,5%**: dor embaixo dos dedos, rigidez, problemas de cicatrização, dedão desviado para o lado oposto e volta do joanete [9]. Uma revisão estimou recidiva em cerca de **1 em cada 4** operados; o número muda conforme a definição usada [12][13].

Plano

Semanas	Calçado	Proteção	Exercícios (Página 7)
1 e 2	Separe os sapatos que apertam o joanete	Protetor, se houver atrito	Ex. 1 e 3, 1x/dia
3 e 4	Sapato com espaço na maior parte do dia	Mantenha o que ajudou	Ex. 1, 2 e 3, 1 a 2x/dia
5 e 6	Mantenha e leve os sapatos à consulta, se for	Veja se ainda precisa	Mantenha

Os volumes são um ponto de partida prático, não um protocolo testado (opinião clínica). A revisão de 2025 sugere cerca de 3 meses de tratamento sem cirurgia antes de pensar em operar [9]. Estas 6 semanas são a primeira metade.

Rastreador

Semanas	Dor ao andar (0–10)	Dor com sapato fechado (0–10)	Calo ou ferida? (S/N)	Dias com exercício	Deixou de fazer algo pela dor? (S/N)
1 e 2					
3 e 4					
5 e 6					

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina.

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra o que você já tentou, e isso pesa na decisão.

Ferida no pé de quem tem diabetes: **volte à Página 3.**

1. Comprar um "corretor" para desentortar o dedão.

Pode aliviar em algumas pessoas, mas não corrige a deformidade [5][9].

2. Operar só pela aparência.

Cirurgia só estética traz risco sem benefício médico [11]. Joanete sem dor e sem limitação não precisa de cirurgia (opinião clínica).

3. Operar "antes que piore".

A indicação segue a dor e a limitação [9]. Não há estudo de boa qualidade mostrando que operar um joanete sem sintoma evite problema no futuro (opinião clínica).

4. Acreditar em recuperação "relâmpago".

Há sapato especial, inchaço e semanas de adaptação [9]. Desconfie de qualquer promessa de prazo ou resultado garantido.

5. Achar que a cirurgia resolve para sempre.

O joanete pode voltar [12][13]. Continuar com calçado adequado depois da cirurgia é sensato (opinião clínica).

Bônus: quem tem diabetes cortar calo em casa.

No pé diabético, a diretriz internacional recomenda tratar qualquer lesão antes que vire úlcera [14]. Isso é trabalho de profissional, e não de lâmina em casa (opinião clínica).

Procure avaliação se:

- A dor **continua** mesmo com sapato adequado, por cerca de 3 meses [9].
- Está **difícil achar sapato** que sirva.
- O calo ou a ferida sobre o joanete **voltam** [9].
- Surgiu **dor embaixo dos outros dedos**, ou o segundo dedo começou a "montar" no dedão (opinião clínica).
- Você tem **diabetes** e o sapato machuca o joanete [14].
- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: o pé parado, em pé e andando, os sapatos que você usa e, conforme o caso, raio-X com o pé apoiado (opinião clínica). A partir disso, o tratamento sem cirurgia é ajustado.

O Dr. Roberto é ortopedista com atuação em cirurgia do joelho. Ele avalia o joanete, orienta o tratamento sem cirurgia e, quando há indicação de operar ou o caso pede, **encaminha a um cirurgião de pé e tornozelo**. O encaminhamento faz parte do cuidado.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Cai Y, Song Y, He M, He W, et al. **Global prevalence and incidence of hallux valgus: a systematic review and meta-analysis.** J Foot Ankle Res. 2023;16(1):63. doi:10.1186/s13047-023-00661-9. PMID: 37726760.
2. Hannan MT, Menz HB, Jordan JM, Cupples LA, et al. **High heritability of hallux valgus and lesser toe deformities in adult men and women.** Arthritis Care Res (Hoboken). 2013;65(9):1515-1521. doi:10.1002/acr.22040. PMID: 23696165.
3. Zhang G, Ma Y, Zhang S. **Determinants and associated factors for hallux valgus: a systematic review and meta-analysis.** BMC Musculoskelet Disord. 2026;27(1):647. doi:10.1186/s12891-026-10054-1. PMID: 42265673.
4. Nguyen US, Hillstrom HJ, Li W, Dufour AB, et al. **Factors associated with hallux valgus in a population-based study of older women and men: the MOBILIZE Boston Study.** Osteoarthritis Cartilage. 2010;18(1):41-46. doi:10.1016/j.joca.2009.07.008. PMID: 19747997.
5. Hurn SE, Matthews BG, Munteanu SE, Menz HB. **Effectiveness of nonsurgical interventions for hallux valgus: a systematic review and meta-analysis.** Arthritis Care Res (Hoboken). 2022;74(10):1676-1688. doi:10.1002/acr.24603. PMID: 33768721.
6. Kwan MY, Yick KL, Yip J, Tse CY. **Hallux valgus orthosis characteristics and effectiveness: a systematic review with meta-analysis.** BMJ Open. 2021;11(8):e047273. doi:10.1136/bmjopen-2020-047273. PMID: 34408037.
7. Zhu Z, Liu Y, Wang L, Liu H. **Effects of exercise combined with external support on hallux valgus angle and pain: a systematic review and network meta-analysis.** Foot Ankle Surg. 2026;32(3):199-212. doi:10.1016/j.fas.2025.09.004. PMID: 40973592.
8. Torkki M, Malmivaara A, Seitsalo S, Hoikka V, et al. **Surgery vs orthosis vs watchful waiting for hallux valgus: a randomized controlled trial.** JAMA. 2001;285(19):2474-2480. doi:10.1001/jama.285.19.2474. PMID: 11368700.
9. Ettinger S, Spindler FT, Marschall U, Polzer H. **Hallux valgus: prevalence and treatment options.** Dtsch Arztebl Int. 2025;122(11):308-314. doi:10.3238/arztebl.m2025.0068. PMID: 40332014.
10. Dias CG, Godoy-Santos AL, Ferrari J, Ferretti M, et al. **Surgical interventions for treating hallux valgus and bunions.** Cochrane Database Syst Rev. 2024;7(7):CD013726. doi:10.1002/14651858.CD013726.pub2. PMID: 39051477.
11. American College of Foot and Ankle Surgeons (ACFAS). **ACFAS Position Statement on Cosmetic Surgery.** Aprovada pela diretoria em novembro de 2023. Disponível em: <https://www.acfas.org/policy-advocacy/policy-position-statements/acfas-position-statement-on-cosmetic-surgery>
12. Ezzatvar Y, López-Bueno L, Fuentes-Aparicio L, Dueñas L. **Prevalence and predisposing factors for recurrence after hallux valgus surgery: a systematic review and meta-analysis.** J Clin Med. 2021;10(24):5753. doi:10.3390/jcm10245753. PMID: 34945049.
13. Lalevee M, de Cesar Netto C, ReSurg, Boubilil D, et al. **Recurrence rates with longer-term follow-up after hallux valgus surgical treatment with distal metatarsal osteotomies: a systematic review and meta-analysis.** Foot Ankle Int. 2023;44(3):210-222. doi:10.1177/10711007231152487. PMID: 36859795.
14. Bus SA, Sacco ICN, Monteiro-Soares M, Raspovic A, et al. **Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2023 update).** Diabetes Metab Res Rev. 2024;40(3):e3651. doi:10.1002/dmrr.3651. PMID: 37302121.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

